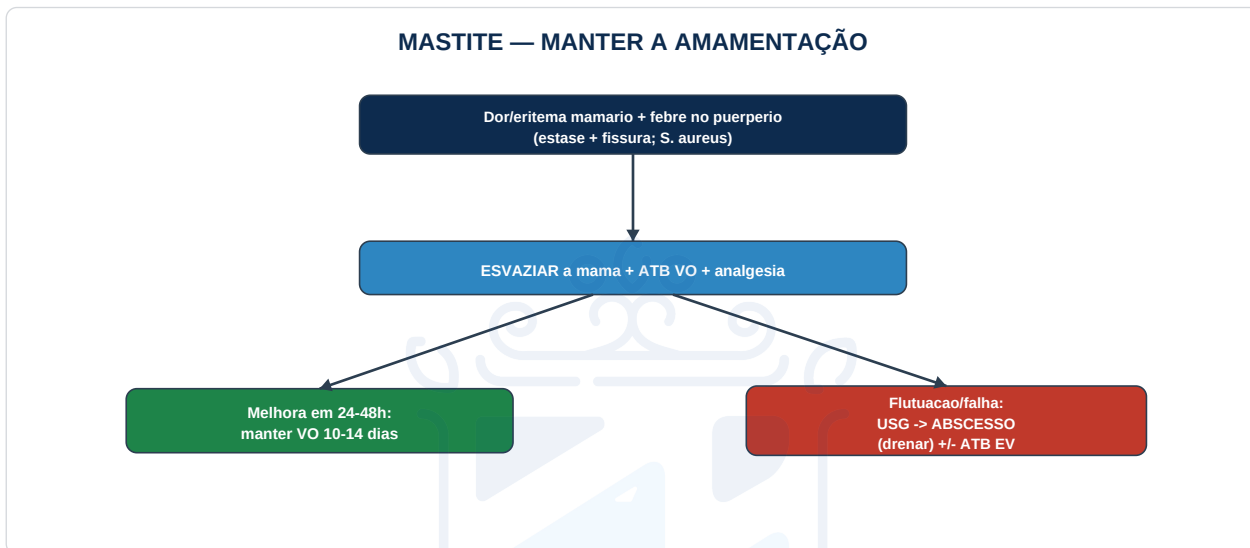


MASTITE — ESVAZIAR A MAMA + ATB

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Inflamação da mama, geralmente infecciosa, comum no puerpério
- Associada à ESTASE do leite e a FISSURAS mamilares
- Agente mais comum: Staphylococcus aureus
- O esvaziamento da mama é parte fundamental do tratamento

QUADRO CLÍNICO E SINAIS DE GRAVIDADE

RECONHECER

- Dor mamária localizada, endurecimento e calor local, eritema EM PLACA
- Febre $\geq 38,3$ C, mal-estar, calafrios, redução da drenagem do leite
- Sinais de gravidade: falha terapêutica em 48-72h, FLUTUAÇÃO (suspeita de abscesso), sepse
- Diagnóstico é CLÍNICO; USG de mama se suspeita de abscesso ou ausência de resposta
- Cultura do leite em casos recorrentes ou graves

CONDUTA GERAL (TODAS AS PACIENTES)

Rx

AMAMENTAÇÃO + MEDIDAS

MANTER o aleitamento materno — contraindicação absoluta é rara
Iniciar a mamada pela mama afetada e ESVAZIAR completamente; ordenha manual/bomba se dor intensa
Compressas MORNAS antes da mamada e FRIAS após
Analgesia: paracetamol ou dipirona; hidratação adequada
Corrigir a PEGA (fissura é porta de entrada)

ANTIBIOTICOTERAPIA

Cenário	Esquema (10-14 dias)
Não complicada (VO, ambulatorial)	Cefalexina 500mg 6/6h OU Dicloxacilina 500mg 6/6h OU Amoxi-clav 875/125mg 12/12h
Alergia à penicilina	Clindamicina 300mg 6/6h
Suspeita de MRSA / falha	Clindamicina OU SMX-TMP (evitar se RN < 2 meses ou prematuro)
Internação (EV)	Oxacilina ou Cefazolina; associar Clindamicina se grave

ABSCESSE MAMÁRIO E INTERNAÇÃO

RED FLAGS

- Suspeitar de abscesso se: área flutuante, dor localizada persistente, febre apesar de antibiótico
- Conduta: DRENAGEM (punção guiada por USG ou cirúrgica — contatar GO/cirurgia) + ATB EV se grave + manter esvaziamento
- INTERNAR se: sinais de sepse, dor incapacitante, falha do tratamento VO, imunossuprimida
- Melhora clínica esperada em 24-48h; ausência de melhora -> reavaliar o diagnóstico (incl. carcinoma inflamatório)
- Complicações: abscesso, desmame precoce, sepse puerperal

CHECKLIST / ALTA

ORIENTAR

- ☐ Manter amamentação e esvaziamento completo da mama afetada
- ☐ Antibiótico VO por 10-14 dias + analgesia + compressas
- ☐ Corrigir a pega; cuidar das fissuras mamilares
- ☐ Retorno em 48-72h ou antes se piora/flutuação/febre persistente
- ☐ Mensagem-chave: mastite NÃO é motivo para suspender a amamentação

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Puérpera lactante com mastite ____ (não complicada/abscesso); mama ____; febre ____.
- USG de mama: ____ (flutuação/abscesso?); resposta ao ATB VO: ____.
- Conduta: esvaziamento + ATB (____), analgesia; drenagem se abscesso.
- Solicito avaliação de GO/cirurgia para drenagem / internação se sepse ou falha.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Puérpera lactante com mastite. Sobre a amamentação, qual a orientação correta?

- A) Suspender a amamentação até o fim do antibiótico
- B) Manter a amamentação e esvaziar completamente a mama (iniciando pela afetada)
- C) Suspender apenas na mama afetada e secar o leite
- D) Trocar por fórmula definitivamente
- E) Amamentar somente após a febre cessar

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o agente etiológico mais comum da mastite puerperal?

- A) Escherichia coli
- B) Staphylococcus aureus
- C) Streptococcus agalactiae
- D) Candida albicans
- E) Pseudomonas aeruginosa

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual achado sugere abscesso mamário (e não apenas mastite)?

- A) Eritema difuso sem flutuação
- B) Área flutuante e febre persistente apesar do antibiótico
- C) Dor leve que melhora com a mamada
- D) Ausência de febre
- E) Boa drenagem do leite

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual antibiótico oral é adequado para mastite não complicada?

- A) Ciprofloxacino
- B) Cefalexina (ou dicloxacilina / amoxicilina-clavulanato)
- C) Nitrofurantoína
- D) Metronidazol isolado
- E) Azitromicina dose única

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual a conduta no abscesso mamário?

- A) Apenas antibiótico oral
- B) Drenagem (punção guiada por USG ou cirúrgica) + antibiótico + manter esvaziamento
- C) Suspender a amamentação e observar
- D) Compressas mornas isoladas
- E) Mastectomia

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A amamentação deve ser MANTIDA na mastite (contraindicação absoluta é rara); inicia-se pela mama afetada e esvazia-se completamente, pois a estase do leite perpetua a infecção. Esvaziar é parte do tratamento.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O *Staphylococcus aureus* é o agente mais comum da mastite puerperal, tendo as fissuras mamilares como porta de entrada.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Área flutuante e febre persistente apesar do antibiótico sugerem abscesso mamário, confirmado por USG, que requer drenagem além do antibiótico.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Mastite não complicada trata-se com cefalexina, dicloxacilina ou amoxicilina-clavulanato VO por 10-14 dias (clindamicina se alergia/MRSA). Quinolona e nitrofurantoína não são indicadas.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O abscesso mamário requer drenagem (punção guiada por USG ou cirúrgica), associada a antibiótico e à manutenção do esvaziamento da mama; ATB EV se quadro grave.

SM24
Suporte ao Plantão Médico